

GUIDA / PRESENTAZIONE

# Monitoraggio degli obiettivi terapeutici

MOT v1.0 · Osservazioni, criteri individuali e decisioni nel tempo.

Una scheda per seguire un obiettivo logopedico senza ridurre il percorso a un voto: **che cosa si cerca di ottenere, in quali condizioni, con quali supporti e sulla base di quali evidenze.**

## 01 Un obiettivo significativo, non soltanto un esercizio

Il punto di partenza è una priorità della persona. Il comportamento target è l'azione osservabile che permette di seguirla. Gli obiettivi possono riguardare acquisizione, mantenimento, compensazione, partecipazione oppure azioni concordate dei partner e dell'ambiente. Il professionista definisce pertinenza e modalità d'impiego. [1, 2, 5]

### Strumento di monitoraggio non standardizzato

MOT organizza dati e sintesi professionali. Non è un test, non produce punteggi normativi, diagnosi, indici di efficacia del trattamento o decisioni automatiche. La scala interna è gestionale e descrittiva, non psicometrica; il dato principale rimane l'evidenza documentata.

## 02 Tre momenti di utilizzo

| ALL'AVVIO                                                          | NELLE RILEVAZIONI                                                | ALLA REVISIONE                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1–S2: definire obiettivo, baseline, misura e criteri individuali. | S3: registrare una seduta o un periodo. S4–S8 solo quando utili. | S9: integrare dati e prospettive, decidere il prossimo passo. S10: panoramica del percorso. |

Per bambini e adulti, con adattamenti a lingue, modalità comunicative, contesti e accessi. La raccolta può includere la persona, caregiver e altri professionisti, mantenendo distinte le fonti. Non è necessario usare la scala o compilare tutte le pagine.

Edizione editoriale del 03/10/2026. Revisione clinica, sperimentazione d'uso e validazione psicometrica non eseguite. Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria una revisione professionale nei contesti previsti. Riferimenti e limiti: G10.

## GUIDA / PERCORSO E RIMANDI

# Una struttura da riutilizzare

Una definizione stabile dell'obiettivo; una nuova rilevazione ogni volta.

| PAGINA                           | FUNZIONE                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 · Identità dell'obiettivo     | Priorità, comportamento target, autore dell'azione, contesto e punto di partenza.     |
| S2 · Regole di rilevazione       | Unità, opportunità, criteri di esito, supporti consentiti e verifica programmata.     |
| S3 · Rilevazione rapida          | Un obiettivo e una condizione per seduta/blocco o periodo chiaramente delimitato.     |
| S4 · Dettaglio delle opportunità | Registro facoltativo: prima risposta, aiuti successivi e regola di conteggio.         |
| S5 · Andamento nel tempo         | Affiancare baseline e rilevazioni confrontabili, senza cancellare le differenze.      |
| S6 · Generalizzazione            | Verificare che cosa avviene con altri partner, materiali, attività o contesti.        |
| S7 · Stabilità e mantenimento    | Documentare ripetibilità e controlli successivi, con intervallo e pratica intercorsa. |
| S8 · Strategie e difficoltà      | Descrivere azioni, risposte, barriere e prospettive della persona e dei partner.      |
| S9 · Revisione dell'obiettivo    | Sintesi, descrittore facoltativo, decisione, responsabilità e prossimo passo.         |
| S10 · Panoramica del percorso    | Più obiettivi affiancati; nessun totale o media dei descrittori.                      |

## ID Collegare senza duplicare

**O01** identifica l'obiettivo; **rev. 01** la sua definizione; **R01** una rilevazione. Se due blocchi hanno condizioni diverse, usa due codici R. Riporta il riferimento della seduta o della fonte, non solo la data di inserimento. Le pagine ripetute conservano codice persona, obiettivo, revisione e data.

Il codice del modello è MOT v1.0; non coincide con la revisione del singolo obiettivo. Nei sistemi digitali, i collegamenti a obiettivo, seduta e documento sono riferimenti da conservare: questo dossier non introduce né modifica funzioni del sito.

GUIDA / DEFINIRE · S1-S2

# Dal bisogno al criterio

Scrivere prima che cosa conta; poi raccogliere i dati.

## 01 Priorità, azione e condizioni

Concorda una priorità espressa in termini di vita quotidiana. Specifica **chi agisce**, che cosa fa di osservabile, con chi, dove, con quali materiali, lingua/modalità e accessi. Se il target è un comportamento del partner, non attribuire il suo risultato alla persona. Obiettivi e preferenze individuali sono centrali nella riabilitazione. [2, 5]

| FORMULAZIONE VAGA             | FORMULAZIONE OSSERVABILE — ESEMPIO FITTIZIO                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Migliorare la comunicazione” | “Durante la pianificazione condivisa di un’attività, esprime una preferenza o un rifiuto riconoscibile tramite parola, gesto concordato o CAA.”              |
| “Con poco aiuto”              | “Dopo l’invito abituale del partner e l’attesa concordata; senza un suggerimento aggiuntivo che anticipi il messaggio. Accessi disponibili descritti in S2.” |
| “Obiettivo raggiunto all’80%” | Definire prima opportunità, risposta osservabile, numero di rilevazioni, supporti e contesti rilevanti. Nessuna soglia comune è fornita da MOT.              |

## 02 Baseline: punto di partenza documentato

La baseline è il riferimento iniziale disponibile: data/periodo, fonte, campione, misura e condizioni. Richiama una rilevazione R o un documento. Se manca, scrivi **“baseline non disponibile”** e pianifica la raccolta: non inserire zero e non ricostruire un valore dalla memoria.

## 03 Criterio individuale e data di riesame

Definisci quale evidenza renderà il target utile nel contesto: accuratezza quando pertinente, frequenza, durata, partecipazione oppure una descrizione verificabile. Specifica quante e quali rilevazioni servono per quella persona, senza importare valori predefiniti. La data di riesame non promette il raggiungimento dell’obiettivo.

### Cambiare un obiettivo non riscrive il passato

Se cambiano target, unità, criteri o supporti ammessi, crea una revisione datata in S9 e nuove S1-S2. Conserva le definizioni precedenti; non presentare le serie come equivalenti senza motivarlo. Una nuova finalità distinta può richiedere un nuovo codice O.

## GUIDA / MISURA · S2-S4

# Che cosa conta come dato

Accuratezza, opportunità e percentuali: solo quando hanno un significato definito.

Scegli una misura coerente con il target: **risposte conformi / opportunità valide**, frequenza in un intervallo, durata, latenza oppure descrizione strutturata. Non tutte le attività si prestano a “giusto/sbagliato”. Nelle scelte personali si osserva l'atto comunicativo concordato, non si valuta quale preferenza sia corretta.

| DEFINIRE PRIMA                  | REGOLA OPERATIVA MOT                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opportunità e unità             | Descrivi inizio, fine e condizioni di accesso. Un turno, una parola e un passaggio di attività non sono la stessa unità.                                      |
| Esito conforme al criterio      | Definisci risposta, completezza, tempo quando pertinente e supporti ammessi. Riporta separatamente risposte parziali o dubbie.                                |
| N · opportunità valide          | Includi gli eventi valutabili secondo le regole stabilite, anche quando il target non è rilevato. Non tenere soltanto le risposte migliori.                   |
| X · esclusioni / non valutabili | Registra quantità e motivo: accesso non disponibile, evento non osservato, interruzione prima dell'avvio. Non sono errori della persona e non devono sparire. |
| Tentativi successivi            | Ripetere o aiutare nella stessa opportunità non crea nuove opportunità, salvo una diversa unità definita prima. Conserva prima risposta e seguito.            |

Per un conteggio osservato usa  $n / N$ , dove  $n$  è il numero di opportunità che soddisfa il criterio definito. La percentuale facoltativa è  $100 \times n / N$ , solo con  $N$  maggiore di zero e dati numerici verificabili.  **$N = 0$ : non calcolabile**, non 0%. Se  $N$  non è noto, usa una nota: non stimare un denominatore da “spesso”.

## Esempio fittizio: la ripetizione non raddoppia il campione

Su 5 opportunità valide, 2 risposte soddisfano il criterio “senza suggerimenti aggiuntivi”; 2 arrivano solo dopo un modello, 1 non è rilevata. Il risultato del criterio è  $2/5 = 40\%$ , non  $4/5$ . Le due risposte dopo modello sono un dato separato, non due nuove opportunità.

Il rifiuto e il bisogno di pausa vanno rispettati e descritti: non equivalgono automaticamente a incapacità o errore. Quando previsti dal target, sono risposte comunicative valide. Non creare privazione, pressione o prove rischiose per aumentare  $N$ ; molte  $X$  limitano l'interpretabilità del dato.

GUIDA / SUPPORTI E FONTI · S3-S4

# Risultato e aiuto restano distinti

“Autonomo” e “con aiuto” non bastano senza una descrizione concreta.

## A Accessi abituali e aiuti aggiuntivi

Documenta gli accessi necessari: comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), ausili sensoriali, materiali leggibili, adattamenti ambientali e tempi compatibili con la persona. MOT li tiene distinti dagli aiuti aggiuntivi diretti a ottenere il target. Un sistema CAA non è, di per sé, un errore o un livello inferiore. Gli interventi CAA considerano modalità multiple, partner e contesti. [3]

| CHE COSA SCRIVERE            | ESEMPIO DI ANNOTAZIONE — FITTIZIO                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo e contenuto             | Invito abituale; indizio semantico; modello verbale; gesto del partner. Riportare ciò che è stato effettivamente fatto.            |
| Momento e frequenza          | Prima della risposta o dopo un tentativo; una volta o ripetuto; tempo d'attesa effettivo quando rilevato.                          |
| Iniziativa e risposta        | Chi avvia l'aiuto? Che cosa fa la persona prima e dopo? L'aiuto modifica l'unità o anticipa la soluzione?                          |
| Etichetta locale facoltativa | “Aiuto lieve” è utilizzabile solo con una definizione scritta per quell'obiettivo. Non è una gerarchia universale né un punteggio. |

## B Separare rilevazione, insegnamento e resoconto

Indica se il blocco è una rilevazione iniziale, pratica con insegnamento, verifica concordata o follow-up. Non mescolare i risultati ottenuti con procedure diverse. Documentazione professionale e note di trattamento distinguono prestazione, intervento/aiuti e piano successivo. [1]

Scrivi **osservazione diretta dal vivo**, **diretta da registrazione**, **riferita dalla persona**, **riferita da caregiver/altro** o **documentale**, con autore e data/periodo. La descrizione “a casa lo fa spesso” non diventa una percentuale né una rilevazione diretta del logopedista.

## Nessuna prova di indipendenza a costo dell'accesso

Non togliere ausili o supporti necessari per misurare una prestazione “pura”. L'aiuto ammesso è parte della definizione del target; una sua modifica richiede di annotare le nuove condizioni. Strategie e trattamento restano decisioni del professionista, non prescrizioni della scheda.

# Scala interna ARMONIA

Facoltativa, descrittiva e riferita all'obiettivo: non psicometrica.

I cinque descrittori proposti servono a orientare la consultazione del percorso. **Non assegnare numeri, medie o un totale.** Non sono tappe obbligate, equidistanti o necessariamente applicabili a un obiettivo di mantenimento. La scelta è professionale, datata e motivata con le rilevazioni richiamate.

| DESCRITTORE                            | QUANDO USARLO E CHE COSA NON IMPLICA                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non emergente nel campione             | Nelle opportunità valide documentate non sono rilevate manifestazioni del target. Non significa abilità assente in generale. Se le condizioni non permettono di osservarlo, non usare questo descrittore.                 |
| Emergente                              | Si documentano manifestazioni iniziali o parziali del target, definite per quell'obiettivo. Riportare esempi, condizioni e aiuti; non dedurre una fase evolutiva.                                                         |
| In acquisizione                        | Il target è documentato più volte nelle condizioni di apprendimento, ma i criteri individuali di uso funzionale non risultano ancora soddisfatti o sufficientemente verificati.                                           |
| Funzionale nel contesto                | I criteri individuali concordati sono documentati nell'attività rilevante, con i supporti dichiarati. Non significa "senza ausili", nella norma o generalizzato.                                                          |
| Generalizzato nei contesti documentati | I criteri concordati sono documentati anche nelle condizioni ulteriori individuate in S2/S6, con evidenze ripetute e fonti specificate. Non estendere il giudizio ad altri contesti e non dedurre mantenimento nel tempo. |

## Quando non scegliere un livello

Usa "Dati insufficienti", "Non osservabile", "Non pertinente alla finalità" oppure "Solo sintesi narrativa", indicando il motivo. Non attribuire il livello peggiore a un dato mancante. Se l'evidenza è contraddittoria, descrivila invece di forzare una categoria.

**Stabilità, mantenimento e generalizzazione restano campi autonomi.** Un target può essere funzionale con ausili, variabile in un contesto nuovo o mantenuto senza ulteriori acquisizioni. Lo stato organizzativo dell'obiettivo — attivo, sospeso, concluso o sostituito — è una decisione diversa dal descrittore.

Le definizioni di questa pagina sono originali del modello MOT. Non riproducono una scala normativa o una procedura di Goal Attainment Scaling e non generano un relativo punteggio.

GUIDA / CONFRONTI · S5-S7

# Nel tempo e fuori dalla seduta

Distinguere andamento, generalizzazione, stabilità e mantenimento.

| DOMANDA               | CHE COSA DOCUMENTARE                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andamento · S5        | Che cosa cambia tra baseline e rilevazioni? Mantieni la stessa definizione dell'obiettivo e annota eventuali differenze di compito, fonte, supporto o misura.                              |
| Generalizzazione · S6 | Che cosa accade con un partner, un'attività, materiali o un contesto ulteriori rispetto a quelli iniziali? Specifica che cosa è nuovo, già praticato o non direttamente allenato.          |
| Stabilità · S7        | Il risultato si ripete in rilevazioni distinte e comparabili? Documenta variazioni, condizioni e limiti; ripetizioni nella stessa seduta non bastano a descrivere la stabilità tra giorni. |
| Mantenimento · S7     | Il risultato è documentato in un controllo successivo? Riporta intervallo, pratica intercorsa, supporti mantenuti e condizioni. Non richiede automaticamente di sospendere il trattamento. |

Generalizzazione e mantenimento sono aspetti distinti anche nella descrizione degli interventi per i suoni del linguaggio; MOT propone campi trasversali, senza trasferire sequenze o criteri di uno specifico trattamento a tutti gli ambiti. [4]

## ! Che cosa rende un confronto fragile

Non confrontare come equivalenti 8/10 risposte con modello e 5/10 senza suggerimenti; possono descrivere compiti differenti. Lingue, partner, accessibilità, durata, criteri, campioni e fonti diversi devono restare visibili. Un risultato favorevole in un contesto nuovo è un'evidenza locale, non generalizzazione universale.

## Percentuali e fonti non si mescolano automaticamente

Conserva n e N di ogni rilevazione. Non fare la media semplice di percentuali con denominatori diversi, né sommare dati riferiti e diretti. Un'eventuale sintesi numerica richiede unità e condizioni omogenee; MOT non calcola medie automatiche. Per campioni piccoli, i dati grezzi e le note sono essenziali.

Non creare situazioni rischiose, togliere accessi o introdurre prove alimentari per documentare un trasferimento. Per deglutizione e alimentazione si richiamano obiettivi e piani già definiti nei percorsi appropriati: nessun esito MOT attesta sicurezza.

GUIDA / REVISIONE · S8-S10

# Decidere il prossimo passo

Un riepilogo utile include anche il punto di vista della persona.

## 01 Strategie, barriere e sostenibilità

In S8 collega la strategia a una rilevazione: chi fa che cosa, che cosa precede, quale risposta segue e quali condizioni cambiano. **“Associata a un esito favorevole” non dimostra efficacia causale.** Distingui difficoltà del compito, barriere ambientali, accesso, fatica riferita, preferenze e informazioni non disponibili.

## 02 Una revisione per lo stesso obiettivo

In S9 confronta le evidenze con i criteri iniziali, indica i limiti e raccogli la prospettiva della persona con modalità accessibili. Il caregiver può integrare, ma non sostituire automaticamente quella prospettiva. La documentazione dei progressi sostiene il riesame degli obiettivi e delle strategie. [1, 5]

| DECISIONE DOCUMENTATA             | CHE COSA PRECISARE                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proseguire / consolidare          | Quale comportamento o condizione verificare ancora e con quali dati.                                          |
| Modificare strategia o condizioni | Che cosa cambia, perché e se il confronto con la serie precedente rimane possibile.                           |
| Riformulare il target             | Nuova revisione o nuovo O; definizione e criteri aggiornati, con data.                                        |
| Sospendere / concludere           | Motivo, accordi, eventuale controllo o passaggio di consegne. Non è una diagnosi o una dimissione automatica. |

### Mantenere una funzione è una finalità legittima

Esempio fittizio: una persona desidera continuare uno scambio settimanale con un familiare usando il taccuino comunicativo e tempi concordati. Il target può essere mantenere quella partecipazione, non aumentare ogni settimana una percentuale. Registrare fonti, esperienza, supporti e controlli; la scala di acquisizione può essere non pertinente. [1, 2]

Il **prossimo passo** specifica azione, responsabile, contesto e data di verifica. S10 offre una panoramica dei diversi obiettivi, non una pagella della persona. Nessun numero di obiettivi conclusi dimostra da solo efficacia, gravità o necessità di dimissione.

## GUIDA / ESEMPIO COMPLETO

# Dai dati a una decisione

Caso interamente fittizio: numeri e criteri illustrativi, non valori consigliati.

**O01 · rev. 01.** Durante la pianificazione di un'attività scelta, la persona comunica una preferenza o un rifiuto riconoscibile e confermato, tramite parola, gesto concordato o CAA. Accessi sempre disponibili; invito abituale e attesa personalizzata; nessun suggerimento aggiuntivo che anticipi il messaggio.

**Criterio scelto solo per questo esempio:** almeno 3 opportunità conformi su 5 valide in due rilevazioni distinte, nella routine concordata. Ogni invito accessibile è una opportunità; i tentativi successivi rimangono nella stessa. Un rifiuto comunicato è valido. Non si forza il numero di opportunità quando la persona interrompe.

| RILEVAZIONE                          | DATI E CONDIZIONI                                                                                                           | LETTURA CIRCOSCRITTA                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R00 · baseline<br>Giorno 1 · diretta | 2/5 senza suggerimenti; 2 dopo modello; 1 non rilevata. X = 2: un accesso indisponibile e un'interruzione prima dell'avvio. | 2/5 = 40% per il criterio scelto. Le X descrivono limiti di accesso, non errori.      |
| R01 · giorno 4<br>Diretta            | 3/5 conformi; 1 dopo modello; 1 non rilevata. X = 0. Stessa routine e accessi.                                              | Prima rilevazione che soddisfa il criterio individuale.                               |
| R02 · giorno 8<br>Diretta            | 4/5 conformi; 1 dopo modello. X = 0. Stessa routine e accessi.                                                              | Criterio documentato una seconda volta; uso funzionale circoscritto a questa routine. |
| R03 · giorno 11<br>Diretta · S6      | Nuovo partner e nuovo luogo: 1/3 conforme; 1 dopo modello; 1 non rilevata.                                                  | Evidenza di trasferimento limitata; non basta per "Generalizzato".                    |
| Fonte riferita<br>Giorno 12          | Il caregiver riferisce "a casa esprime più scelte", senza numero di opportunità.                                            | Nota separata. Non si trasforma in n/N e non si aggiunge ai dati diretti.             |

**Sintesi in S9:** "Funzionale nel contesto" motivato da R01–R02. La baseline ha limiti di accesso dichiarati. Generalizzazione non ancora sufficientemente documentata; mantenimento a distanza da verificare. Non si attribuisce il cambiamento alla terapia sulla sola base di questi dati.

Prossimo passo fittizio: mantenere gli accessi e programmare osservazioni concordate con il nuovo partner; descrivere separatamente il suo comportamento di supporto. Non aggiungere aiuti o cambiare criteri senza documentarlo.

GUIDA / LIMITI E FONTI

# Ambito dell'edizione

Le fonti sostengono principi generali; non validano il modello MOT.

**Non è una valutazione diagnostica né una misura psicometrica.** MOT non stabilisce normalità, gravità, prognosi, sicurezza della deglutizione o efficacia di un trattamento. Non sostituisce valutazioni, protocolli validati, misure specifiche appropriate o il piano clinico. Non è una versione di GAS o NOMS.

**Scelte originali ARMONIA:** campi, codici, esempi, regole di conteggio e definizioni della scala sono soluzioni editoriali di questo modello. Non sono item copiati dalle fonti. Gli esempi non prescrivono target, numero di opportunità, tempi, tecniche o criteri per una persona reale.

**[1] ASHA — Documentation in Health Care**

<https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/documentation-in-health-care/>

Obiettivi funzionali, dati di seduta, aiuti, confronto e revisione. Fonte professionale statunitense: non trasferisce requisiti assicurativi o legali al contesto italiano.

**[2] WHO — Rehabilitation**

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>

Orientamento alle preferenze individuali, al funzionamento e alla partecipazione; sostegni e finalità di mantenimento.

**[3] ASHA — Augmentative and Alternative Communication**

<https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/augmentative-and-alternative-communication/>

Modalità multiple, accessi, partner e contesti; documentazione degli aiuti senza confonderli con gli ausili comunicativi.

**[4] ASHA — Speech Sound Disorders: Articulation and Phonology**

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology/>

Distinzione tra acquisizione, generalizzazione e mantenimento nello specifico ambito del parlato; nessun trasferimento di norme o sequenze obbligate.

**[5] ASHA — Aphasia**

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/>

Obiettivi individuali e partecipazione; prospettiva della persona e dei partner e adattamenti contestuali.

Fonti consultate il 03/10/2026. I richiami [1]–[5] indicano i principi di riferimento, non un'approvazione di ARMONIA da parte delle organizzazioni citate.

## MOT v1.0 · Stato editoriale

Edizione completa sul piano editoriale. Revisione clinica, sperimentazione d'uso e validazione psicometrica non eseguite. Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria revisione professionale nei contesti previsti. Conservare versione, autore e data delle compilazioni.